VETALYX — Dossier de Présentation

ONE-PAGER — Vetalyx en une page

Accroche. Vetalyx transforme l'allergologie vétérinaire en un acte de routine pour les praticiens généralistes en comblant le vide entre les tests rapides indifférenciés et les solutions moléculaires premium. Grâce à une technologie point-of-care abordable, le projet permet de réduire le parcours diagnostique de 4 mois à une prise en charge immédiate en consultation.

Chiffres clés - **10-15 %** — Prévalence de la dermatite atopique dans la population canine (Cornell University) - **528 M$** — Taille projetée du marché mondial du diagnostic allergologique en 2031 - **35-39 €** — Prix vétérinaire d'un test rapide, conçu pour l'achat d'impulsion - **7,2 M€** — Chiffre d'affaires visé en Année 5 - **58,3 %** — Marge d'EBITDA cible à maturité

Avantages concurrentiels 1. **Panel régionalisé** — Trois SKUs spécifiques adaptés aux flores botaniques européennes (Nord-Ouest, Méditerranée, Europe Centrale), là où les concurrents proposent des panels génériques. 2. **Immédiateté clinique** — Un résultat en 15 minutes permettant une orientation diagnostique et une discussion avec le propriétaire sans délai de laboratoire. 3. **Écosystème captif** — L'automate DX Reader verrouille la consommation de réactifs microarray tout en standardisant les rapports cliniques.

Go-to-market (3 phases) - **Phase 1 — Validation (An 1)** — KOL Seeding auprès de 5-10 dermatologues référents en France et Belgique pour asseoir la preuve clinique. - **Phase 2 — Accélération (An 2-3)** — Conquête des early adopters généralistes et expansion géographique vers l'Italie et l'Espagne. - **Phase 3 — Scale-up (An 3-5)** — Distribution massive via les centrales d'achat (Centravet, Alcyon, etc.) et pénétration du marché allemand.

Projections financières

(en €)	Année 1	Année 3	Année 5
Chiffre d'affaires	299 700	2 295 375	7 209 585
EBITDA	40 980	968 564	4 203 383
Marge EBITDA	*13,7 %*	*42,2 %*	*58,3 %*

Attentes vis-à-vis de l'expert. Nous recherchons un vétérinaire de formation, expert en stratégie marketing, capable de porter la crédibilité scientifique du projet face aux KOL tout en pilotant l'exécution du déploiement commercial à l'échelle européenne. Sa mission sera de transformer une base technique solide en un standard de soin incontournable pour le généraliste.

Le dossier détaillé suit ci-dessous.

PARTIE I — LE PROJET

2. Genèse et vision

D'où vient Vetalyx

Le projet est né d'une observation de terrain : les propriétaires d'animaux confrontés à des démangeaisons chroniques, des otites récidivantes ou des lésions cutanées errent souvent entre

généraliste, spécialiste et régimes d'éviction empiriques. Le diagnostic allergologique vétérinaire existe, mais il est lent, coûteux et concentré dans les mains de quelques laboratoires et cliniques spécialisées.

Les fondateurs, ont identifié chez le fabricant chinois Zheda Dixun une base technique sérieuse — un microarray IgE couvrant 96 allergènes, des tests rapides à lecture visuelle, et un lecteur automatisé — mais dont le panel était calibré pour le marché asiatique, pas pour l'Europe.

L'enjeu était donc double : adapter techniquement le panel aux profils allergéniques européens, et construire un modèle commercial qui rende l'allergologie accessible au généraliste.

La vision

> Faire de l'allergologie vétérinaire un acte de routine en clinique généraliste, pas un luxe de spécialiste.

Cela signifie : - Un test que le vétérinaire peut réaliser pendant la consultation, pas après. - Un résultat qu'il peut interpréter avec le propriétaire dans la même pièce. - Un prix qui ne dissuade pas — et qui laisse une marge attractive à la clinique. - Un panel cliniquement pertinent pour sa région, pas un copier-coller de catalogue chinois.

Pourquoi maintenant

Trois vents porteurs :

1. **Croissance du marché pet care** : +6 à 8 % par an, avec une médicalisation croissante des animaux de compagnie.

2. **Maturité réglementaire** : le cadre IVDR 2017/746 et les procédures d'importation vétérinaire sont identifiés et en cours de documentation pour un nouvel entrant.

3. **Vide concurrentiel** : entre les tests rapides chinois low-cost (non différentiables) et les solutions moléculaires premium (Nextmune PAX, Heska ALLERCEPT), le segment du milieu de gamme — test fiable, rapide, régionalisé, abordable — est inoccupé.

PARTIE II — LE PRODUIT ET LA CLINIQUE

3. Le problème clinique

La dermatite atopique canine (DAC) est la première cause de consultation dermatologique chez le chien. Elle affecte 10 à 15 % de la population canine[1], avec des prédispositions raciales marquées (Bouledogue français, Labrador, Westie, etc.). Chez le chat, les manifestations sont plus variées — dermatite miliaire, alopécie extensive, complexe granulome éosinophilique — mais la composante allergique est tout aussi prégnante.

Le parcours diagnostique actuel est long et frustrant pour toutes les parties :

Étape	Délai typique	Coût cumulé
Consultation généraliste	J0	40-60 €
Traitement symptomatique (corticoïdes, antihistaminiques)	J0-J30	30-80 €
Régime d'éviction empirique	J30-J90	60-120 €
Consultation spécialiste dermatologue	J90+	80-150 €
Test allergologique labo (ELISA/microarray)	J90-J105	85-180 €

Étape	Délai typique	Coût cumulé
Résultats + plan d'immunothérapie	J105+	200-400 €/an

Au total, un propriétaire peut attendre et dépenser **environ 270 €** avant d'obtenir un diagnostic allergologique étayé. Beaucoup abandonnent avant.

Le généraliste, lui, est démuni : il sait que le prurit est probablement allergique, mais il n'a pas d'outil pour objectiver la piste allergénique dans sa consultation. Il traite les symptômes, pas la cause.

---

4. Notre solution technique

Vetalyx propose deux produits complémentaires, utilisables seuls ou en séquence, pour équiper le vétérinaire généraliste après le diagnostic clinique.

Test rapide 6 lignes IgE — L'outil de triage

Le test rapide est le produit d'entrée. Il répond au besoin le plus immédiat du généraliste : en 15 minutes, pendant la consultation, obtenir une orientation sur le profil de sensibilisation IgE du patient.

Caractéristiques techniques :

Paramètre	Valeur
Format	Cassette immunochromatographique à lecture visuelle
Échantillon	Sérum, plasma ou sang total (20 µL)
Durée	10-15 minutes
Conservation	2-30 °C, 24 mois
Allergènes	6 lignes mixtes (mélanges régionaux)
Lecture	Visuelle (bandes colorées) — pas d'équipement requis

Les 3 SKUs régionaux (décision validée — DEC-002) :

SKU	Marché	Lignes allergéniques
VTX-EU-NW	France, Benelux	Mites (D. pteronyssinus + D. farinae), graminées, bouleau/aulne/noisetier, acariens de stockage, puce, moisissures
VTX-EU-MED	Sud France, Italie, Espagne	Mites, graminées, olivier, cyprès, pariétaire, armoise/ambroisie
VTX-EU-CE	Allemagne, Europe centrale	Mites, graminées, bouleau, armoise/ambroisie, acariens de stockage, moisissures

Pourquoi 6 lignes mixtes plutôt que des allergènes individuels : - Une ligne = un groupe d'allergènes cliniquement cohérent (ex. « pollens d'arbres précoces »). - Ce format génère un **effet de dilution** qui réduit naturellement le bruit de fond IgE, y compris les interférences CCD (cross-reactive carbohydrate determinants). - Le résultat est binaire par ligne : positif / négatif. Assez pour orienter, pas assez pour conclure — c'est un triage, pas un diagnostic de précision. - La confirmation et la finesse sont apportées par le microarray (Tier 2).

Microarray IgE — L'outil de confirmation et de planification

Le microarray est le produit de deuxième niveau. Il est utilisé quand le test rapide a identifié une sensibilisation, et que le vétérinaire souhaite préciser le ou les allergènes responsables pour envisager une immunothérapie spécifique. Il n'est pas incorporé dans la stratégie de demarrage.

Caractéristiques techniques :

Paramètre	Valeur
Format	Microarray protéique (96 spots)
Allergènes	46 inhalants + 50 aliments
Échantillon	Sérum ou plasma (100 µL)
Conservation	2-8 °C, 24 mois
Lecture	DX Reader automatisé (3 min pour 15 échantillons)
Résultat	Rapport quantitatif imprimable, exportable

Le DX Reader n'est pas un accessoire — c'est un actif stratégique : - Lecture automatisée standardisée (pas d'interprétation visuelle subjective) - Calibration et traçabilité des lots - Intégration possible avec le LIS (Laboratory Information System) de la clinique - Effet de lock-in : une fois le lecteur installé, les consommables Vetalyx sont le chemin naturel - Compatible avec les deux formats (microarray + immunoblot rapide)

Adaptation du panel à l'Europe

Le microarray DIXUN couvre déjà correctement les **acariens** (9 espèces dont D. pteronyssinus, D. farinae, acariens de stockage) et les **moisissures** (Penicillium, Cladosporium, Aspergillus, Alternaria).

Les gaps identifiés et en cours de négociation avec DIXUN :

Gap	Priorité	Marchés concernés
Graminées (phléole, ivraie, dactyle, fétuque, pâturin)	Haute	Tous
Olivier	Haute	MED (Italie, Espagne, Sud France)
Cyprès	Haute	MED
Aulne, noisetier	Haute	NW + CE
Pariétaire judaica/officinalis	Haute	MED
CCD blocker ou marqueur CCD	Haute (v2)	Tous
Malassezia pachydermatis	Moyenne	Tous

Si DIXUN ne peut pas reformuler complètement avant le lancement, le plan B est documenté : lancer avec un microarray générique + tests rapides régionaux, et affiner itérativement après les premiers retours KOL.

---

5. Positionnement clinique

Le message canonique

> **Vetalyx cartographie la sensibilisation aux IgE spécifiques chez le chien et le chat pour soutenir la prise de décision vétérinaire dans les suspicions de maladie allergique, notamment l'atopie environnementale et la planification de l'immunothérapie.**

Ce message a été calibré pour être à la fois cliniquement exact, réglementairement défendable et commercialement distinctif.

Workflow clinique : où se place le test Vetalyx

Une objection fréquente des vétérinaires est la suivante : « Le diagnostic de dermatite atopique canine est clinique (critères de Favrot). Pourquoi utiliser un test IgE ? »

La réponse est que Vetalyx n'intervient **pas au stade du diagnostic**, mais **après celui-ci** :

1. **Diagnostic clinique** — Le vétérinaire pose le diagnostic de DAC sur la base des critères de Favrot (prurit, atteinte des zones caractéristiques, évolution chronique, exclusion des diagnostics différentiels). Cette étape est inchangée.
2. **Cartographie des sensibilisations** — Une fois le diagnostic posé, le test rapide Vetalyx identifie les groupes d'allergènes auxquels le patient est sensibilisé. Ce n'est pas un test diagnostique, c'est un outil de **phénotypage allergénique**.
3. **Planification thérapeutique** — Le microarray confirme les allergènes spécifiques et permet au vétérinaire de discuter avec le propriétaire d'un plan d'éviction ou d'une immunothérapie spécifique.

En d'autres termes, Vetalyx ne remplace pas la clinique — il l'équipe.

Ce que Vetalyx peut affirmer

Allégation	Formulation autorisée
Détection	Détecte la sensibilisation aux IgE spécifiques d'un allergène
Orientation clinique	Sert d'outil de support à la décision pour orienter la prise en charge de la dermatite atopique
Aide au régime	Aide à identifier les allergènes candidats pour un régime d'éviction ou une discussion sur l'immunothérapie
Usage	Réservé à l'usage professionnel vétérinaire
Interprétation	Les résultats doivent être interprétés avec l'anamnèse, les signes cliniques et le diagnostic différentiel

Ce que Vetalyx ne doit jamais dire

Terme ou allégation interdite	Raison
« Diagnostique l'allergie »	Le test ne diagnostique pas l'allergie à lui seul. Le diagnostic de DAC reste clinique (critères de Favrot).
« Diagnostique l'allergie alimentaire »	Le régime d'éviction/provocation reste le gold standard. Le panel alimentaire est classé P2 (différé) — toute communication doit préciser qu'il s'agit d'un outil d'aide à l'orientation, pas d'un diagnostic autonome.
« Prédit la réaction clinique »	Le test mesure une sensibilisation, pas une réponse clinique à l'exposition.
« Intolérance »	L'intolérance est non-IgE dépendante, hors périmètre du test.
« Remplace le régime d'éviction »	Faux et dangereux cliniquement.
« Panel universel européen »	Sans qualification régionale, l'allégation est trompeuse.

Positionnement concurrentiel sur l'axe clinique

Vetalyx n'est pas un précurseur technologique. Nextmune PAX, avec ses 250-300 spots moléculaires et son CCD blocking intégré, reste la référence scientifique. Heska ALLERCEPT bénéficie de 35 ans d'historique clinique.

Vetalyx est un **précurseur de modèle d'affaires** : il apporte l'allergologie dans la clinique généraliste, là où elle n'était pas économiquement viable.

Critère	Nextmune PAX	Heska ALLERCEPT	Vetalyx
Type	Diagnostic moléculaire de précision	Panel IgE classique	Triage clinique + confirmation
Allergènes	250-300 spots moléculaires	Panels régionaux	6 lignes mixtes + microarray 96 spots
Temps de rendu	1-5 jours	Variable	15 min (rapide) / 1 jour (microarray)
Prix par test	85-180 €	80-150 €	35-39 € (rapide) / 50-70 € (microarray)
CCD blocking	Intégré	Variable	Documenté v1, intégré v2
Cible naturelle	Dermatologues, labos	Spécialistes, cliniques équipées	**Généralistes**
Écosystème	Immunothérapie intégrée	Gamme complète	Lecteur DX + logiciel

La question du CCD

Le CCD (cross-reactive carbohydrate determinant) est un motif glucidique présent sur de nombreux allergènes végétaux. Il peut générer des faux positifs IgE. Nextmune l'a résolu en intégrant un CCD blocker.

Position Vetalyx (DEC-001) : - Le risque CCD est documenté et divulgué dans les guides d'interprétation. - Le format « lignes mixtes » du test rapide génère un effet de dilution qui réduit mécaniquement l'impact CCD. - La validation analytique inclut un test sur ≥ 10 sérums de référence anti-MUXF3 (CCD-positifs). - L'intégration d'un CCD blocker est planifiée en v2, conditionnée aux données KOL terrain.

Cette position est défendable car Vetalyx est positionné comme un test de triage, pas un diagnostic de précision. Les guidelines EAACI 2021 et ACVD (Olivry & Mueller 2018) distinguent ces deux niveaux d'exigence.

Validation clinique en cours

Axe	Protocole	Cible	Statut
KOL dermatologues	n ≥ 30 cliniques, scoring par allergène (must-have / utile / optionnel / non pertinent)	Panel EU validé	Protocole écrit
Essai utilisabilité	Clinique vétérinaire Simon (Liège) — test rapide en conditions réelles	Ergonomie, interprétation	Réalisé (mai 2026)
DBS (Dried Blood Spot)	Sous-protocole KOL — buvard pour collecte déportée, avec protocole de stabilisation strict (séchage contrôlé, ensachage avec dessiccant, conservation 2-8 °C ou −20 °C)	Extension réseau sans infrastructure froide	Protocole écrit

Le dossier technique et clinique fusionné (bilingue FR/EN) est prêt à être soumis aux partenaires et aux KOL.

PARTIE III — LE MARCHÉ

6. Marché cible et potentiel

Le marché mondial

Indicateur	Valeur
Marché mondial (2024)	312 M$
Projection (2031)	528 M$
CAGR	7,7 %
Facteurs de croissance	Médicalisation des animaux, premiumisation des soins, offre point-of-care émergente

Le marché européen

Population animale (FEDIAF 2025) :

Pays	Chiens	Chats	Cliniques vétérinaires
France	7,6 M	14,9 M	~7 500
Allemagne	10,5 M	15,7 M	~9 000
Italie	8,8 M	10,2 M	~6 500
Espagne	9,5 M	6,0 M	~6 000
Belgique	2,1 M	3,1 M	~1 500

Le marché français du diagnostic vétérinaire est estimé à 250 M€, en croissance de 8 % par an. Le segment allergologique représente environ 10-12 M€, avec une forte sous-pénétration en médecine généraliste.

Segmentation et cibles

Segment	Part des cliniques	Pénétration allergo actuelle	Potentiel Vetalyx
Cliniques généralistes	~70 %	Très faible (< 5 % équipées)	**Cœur de cible**
Cliniques spécialisées (dermatologie)	~15 %	Élevée	Influence, KOL
Laboratoires d'analyse	~15 %	Saturée	Complément

La thèse d'investissement repose sur l'hypothèse que le segment généraliste, quasi vierge en allergologie de première intention, représente un gisement de volume largement supérieur au segment spécialiste actuel.

Modèle d'estimation du potentiel France (P0)

> ⚠ Ce tableau estime le **potentiel de marché théorique** si le produit atteignait une adoption large. Les taux de 10 à 40 % sont une projection de capacité marché, non un objectif commercial. Le business plan (Partie V) reflète les objectifs réels, basés sur une montée en charge progressive avec un nombre de cliniques effectivement équipées nettement inférieur (phase KOL → early adopters → distribution).

Année	Taux d'adoption	Cliniques équipées	Tests/mois/clinique	Volume annuel	CA France estimé
Année 1	10 %	750	10	90 000	3,2 M€
Année 2	20 %	1 500	12	216 000	7,6 M€
Année 3	30 %	2 250	14	378 000	13,2 M€
Année 4	35 %	2 625	14	441 000	15,4 M€
Année 5	40 %	3 000	15	540 000	18,9 M€

Hypothèses : prix moyen 35 € HT/test, croissance modérée du nombre de tests par clinique.

Le potentiel EU5 à maturité est estimé à **45-55 M€** en appliquant des taux d'adoption différenciés par marché.

---

7. Paysage concurrentiel

Les forces en présence

	Nextmune PAX	Heska (Antech)	IDEXX	Laboklin	Tests chinois génériques	Vetalyx
Position	Leader EU allergie moléculaire	Leader US, expansion EU	Référence labo global	Labo EU spécialisé	Low-cost indifférencié	**Triage clinique + confirmation**
Allergènes	250-300 spots	Panels régionaux	Envoi labo	200+ extraits	3-5 allergènes	6 lignes + 96 spots
CCD	Intégré	Variable	Variable	Variable	Absent	Documenté v1
Prix/test	85-180 €	80-150 €	60-120 €	70-140 €	5-15 €	35-39 € / 50-70 €
Délai résultat	1-5 jours	3-7 jours	7-14 jours	1-6 jours	10-15 min	15 min / 1 jour
Présence	70+ pays, 1 200+ ETP	Global (Mars)	Global	Europe	Marchés émergents	France P0 → EU5
Écosystème	Immunothérapie intégrée	Gamme complète	Réseau labos	Labo + envoi	Aucun	DX Reader + logiciel

Analyse des forces concurrentielles

Nextmune PAX est le concurrent le plus redoutable sur le plan scientifique. Plateforme moléculaire avec CCD blocking intégré et intégration verticale (test + immunothérapie). Leur point faible : prix (85-180 €) et délai (1-5 jours) les cantonnent au segment spécialiste.

Heska (racheté par Mars/Antech) : force de frappe commerciale massive, historique depuis 1985. Leur point faible : intégration post-acquisition crée des lourdeurs, stratégie EU moins lisible.

IDEXX : domination du diagnostic vétérinaire général, mais pas de gamme allergologique point-of-care. Modèle de labo centralisé structurellement lent. Concurrent indirect.

Laboklin : leader des laboratoires d'analyse vétérinaire en Europe. Leur limitation est le modèle d'envoi postal (1-6 jours de délai).

Tests chinois génériques : menace de commoditisation à 5-15 €, mais crédibilité clinique nulle et absence de validation régionale.

La niche Vetalyx

Le segment **milieu de gamme point-of-care** — entre le low-cost chinois et le premium moléculaire — est structurellement inoccupé. Trois raisons :

1. Les leaders (Nextmune, Heska) n'ont pas intérêt à descendre en gamme : cela cannibaliserait leurs marges.
2. Les fabricants chinois n'ont pas la capacité à construire une crédibilité clinique européenne par eux-mêmes.
3. Les généralistes n'ont pas l'infrastructure pour adopter les solutions spécialistes.

Vetalyx s'insère dans cette brèche avec le trépied : **technologie adaptée + crédibilité clinique + modèle économique généraliste**.

Résilience face à la dépendance fournisseur

Une objection légitime est la dépendance à un fournisseur unique (Zheda Dixun). Cette dépendance est réelle, mais elle est structurellement asymétrique :

- **L'interdépendance est structurelle.** Le fabricant chinois dispose d'une base technique compétitive mais n'a pas la capacité — ni l'incitation économique — à construire seul une crédibilité clinique sur le marché européen. L'adaptation du panel, la validation KOL, la conformité réglementaire et le réseau de distribution constituent une couche de valeur que DIXUN ne peut pas répliquer sans partenaire local.
- **Barrière à la vente directe :** les cliniques vétérinaires européennes n'achètent pas de tests diagnostiques à un fabricant chinois inconnu sans intermédiaire crédible. Le risque de désintermédiation est faible tant que Vetalyx détient la relation clinique et la marque.
- **Plan de backup :** qualification de fournisseurs secondaires identifiés dans le plan de mitigation — les catalogues produits sont en cours d'évaluation. Les noms des fournisseurs alternatifs sont documentés en interne et ne sont pas divulgués dans ce document.

PARTIE IV — LA STRATÉGIE COMMERCIALE

8. Go-to-Market

Séquençage géographique

Phase	Marché	Objectif	Durée
P0 — Validation	France + Belgique (Benelux)	Preuve clinique KOL, premières données de vente, rodage logistique	Année 1-2
P1 — Expansion Sud	Italie + Espagne	Volume Méditerranée, panel MED validé	Année 2-3
P2 — Expansion Centre	Allemagne	Barrière qualitative élevée	Année 3-4

Pourquoi la France en premier : - Marché vétérinaire structuré (7 500 cliniques). - Présence de KOL dermatologues reconnus (Maisons-Alfort, VetAgroSup). - Proximité géographique et culturelle avec la Belgique (siège SRL). - Partenaire distributeur déjà engagé contractuellement.

Phases de pénétration

Phase 1 — KOL seeding (mois 0-6, 5-10 cliniques) - Recrutement de cliniques dermatologiques de référence. - Objectif : scoring structuré de chaque allergène (must-have / utile / optionnel / non pertinent). - Production d'études de cas co-écrites pour La Semaine Vétérinaire. - Ce n'est pas une phase de vente — c'est une phase de preuve.

Phase 2 — Early adopters (mois 6-12, 50-100 cliniques) - Extension aux cliniques généralistes « innovatrices précoces ». - Offre de lancement : lecteur DX Reader offert pour engagement 6 mois de consommables. - Objectif : mesurer le taux de réachat (indicateur fiable de satisfaction produit). - Recrutement via congrès (AFVAC) et prescription KOL.

Phase 3 — Distribution (mois 12-24) - Référencement chez les grossistes vétérinaires (Centravet, Alcyon, Coveto). - Marge distributeur 25-30 % (standard sectoriel dans la distribution vétérinaire française), engagement de volume minimum, exclusivité territoriale temporaire.

Phase 4 — Expansion EU (année 2-4) - Même séquençage KOL → early adopters → distribution pour chaque nouveau marché.

Canaux de distribution

Canal	Phase	Rôle	Marge distributeur
Vente directe KOL	Phase 1	Preuve clinique	N/A (gracieux)
Vente directe early adopters	Phase 2	Volume initial, feedback	0 % (direct)
Grossistes vétérinaires	Phase 3	Volume, couverture nationale	25-30 %
Congrès et salons	Continu	Visibilité, recrutement	N/A

---

9. Mix marketing

Prix et positionnement prix

Produit	Prix vétérinaire HT	Prix public TTC conseillé	Marge clinique
Test rapide 6 lignes	35-39 €	55-60 €	~35 %
Microarray 96 spots	50-70 €	80-100 €	~35 %
DX Reader	1 500-2 000 € (offert sur engagement)	N/A	N/A

Logique de prix : - Le test rapide est un **achat d'impulsion diagnostique** : le vétérinaire le propose en fin de consultation, le propriétaire repart avec un résultat. À 35 €, le frein psychologique est bas. - Le microarray est un **acte de deuxième niveau**, justifié par la valeur clinique ajoutée. - Le lecteur est offert sur engagement — modèle de lock-in vertueux.

Communication

Communication 100 % B2B vétérinaire. Le ton est celui d'un pair qui parle à un pair.

1. **Crédibilité clinique** : articles dans La Semaine Vétérinaire, présentations AFVAC/ESVD, publications co-signées KOL.
2. **Démonstration** : stands congrès, vidéos tutorielles, webinaires mensuels animés par un KOL.
3. **Preuve sociale** : témoignages cliniques pilotes, études de cas, « utilisé par X cliniques en France ».
4. **Support clinique** : hotline vétérinaire, guide d'interprétation illustré, FAQ clinique en ligne.

---

10. Plan d'action 90 jours

Période	Actions	Livrable
J0-J15 — Lock technique	Demander dossier technique DIXUN complet, négocier reformulation tests rapides EU	Dossier technique validé
J15-J30 — Spécification clinique	Définir panel P0 France/Belgique, guide d'interprétation, questionnaire KOL	Guide v1 + questionnaire
J30-J60 — Preuve KOL	Contacter 5-10 KOL dermatologues, présenter dossier, recueillir scorings allergènes	KOL signés + scoring matrix
J60-J90 — Package lancement	Finaliser panels EU, IFU/étiquetage, grille tarifaire, deck distributeur, protocole pilote	Package lancement prêt

---

PARTIE V — LE BUSINESS PLAN

11. Modèle de revenus

Ligne 1 — Tests rapides (volume) - Produit d'appel et de récurrence. Marge brute : ~47 % en Année 1, progressant vers ~70 % à maturité grâce à l'effet volume.

Ligne 2 — Microarray + lecteur (valeur) - Produit de confirmation et de fidélisation. Marge brute cible : ~60 %.

Revenus contractuels : - 110 000 € HT sur deux milestones (66 K€ signature + 44 K€ go-live). - Stock initial 50 000 € fourni sans paiement immédiat — remboursement conditionnel aux ventes.

---

12. Projections financières 5 ans

(en €)	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Chiffre d'affaires total	**299 700**	**856 088**	**2 295 375**	**4 490 850**	**7 209 585**
COGS	158 760	453 495	906 990	1 496 460	2 054 178
Marge brute	**140 940**	**402 593**	**1 388 385**	**2 994 390**	**5 155 407**
Taux de marge brute	*47 %*	*47 %*	*60 %*	*67 %*	*72 %*
OPEX (hors salaires)	99 960	140 688	182 621	221 362	251 244
Charges salariales	0	91 000	237 200	420 970	700 780
Total OPEX	**99 960**	**231 688**	**419 821**	**642 332**	**952 024**
EBITDA	**40 980**	**170 905**	**968 564**	**2 352 058**	**4 203 383**
Marge d'EBITDA	*13,7 %*	*20,0 %*	*42,2 %*	*52,4 %*	*58,3 %*
Résultat avant impôt	**40 980**	**170 905**	**968 564**	**2 352 058**	**4 203 383**

Commentaire des projections

Année 1 — Lancement (300 K€) : volume modeste, France KOL/early adopters. COGS 53 %, pas de salaires. Preuve de concept.

Année 2 — Accélération (856 K€, +186 %) : début distribution grossistes, premiers recrutements. Point mort opérationnel franchi.

Année 3 — Scale France (2,30 M€, +168 %) : 30 % des cliniques équipées, effet volume sur COGS (40 %), début expansion IT/ES. EBITDA 969 K€.

Année 4 — Expansion EU (4,49 M€, +96 %) : expansion géographique devient moteur principal. Marge EBITDA > 50 %.

Année 5 — Maturité (7,21 M€, +61 %) : croissance normalisée, marge brute 72 %, EBITDA 58 %. Autofinancement.

Hypothèses clés

Hypothèse	Valeur	Sensibilité
Prix moyen test rapide	35 €	-10 % prix = +15-20 % volume estimé
Tests par clinique par mois	10 → 15 (sur 5 ans)	Conservateur vs benchmark (20-30)

Hypothèse	Valeur	Sensibilité
Taux d'adoption France à 5 ans	40 %	Scénario haut : 50 % (+25 % CA) / Bas : 25 % (-37 % CA)
COGS en % du CA	53 % → 28 %	Amélioration progressive
Expansion géographique	Année 3 (IT+ES), Année 4 (DE)	Retard 12 mois = -20 % CA année 5

---

13. Besoins et financement

Phase pré-lancement (couverte)

- 110 000 € HT contractuels.
- 50 000 € stock initial (remboursement conditionnel).

Phase scale-up (à financer)

- Besoin estimé : **300-500 K€** (année 2-3).
- Utilisation : recrutement commercial, marketing congrès, BFR stock, expansion IT/ES.

Roadmap RH

Rôle	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Direction générale	Fondateur	Fondateur	Fondateur	Fondateur	Fondateur
Direction commerciale & marketing	—	**1**	1	1	1
Commercial terrain France	—	1	2	2	2
Commercial terrain IT/ES	—	—	1	2	2
Support technique/clinique	—	—	1	1	1
RA/Qualité	—	—	1	1	1
Admin/Finance	—	—	—	1	1
Total ETP	**0**	**2**	**6**	**8**	**8**

Note Année 1 : les fonctions support (technique, clinique, réglementaire) sont assurées par le fondateur et l'équipe projet PKA — spécialistes en clinique vétérinaire, finance, réglementaire et juridique — jusqu'au recrutement des premiers salariés en Année 2.

---

14. Questions ouvertes

1. **Positionnement** : le « triage clinique en médecine généraliste » est-il le bon angle ?
2. **SKUs régionaux** : 3 variantes ou 1 panel européen générique + ajustements logiciels ?
3. **Priorité canal** : grossistes ou vente directe avec force commerciale dédiée ?
4. **Recrutement KOL** : comment recruter 5-10 KOL sans budget marketing significatif ?
5. **Pricing** : 35-39 € optimal, ou 45-50 € signalerait-il plus de qualité ?
6. **Timing** : France → IT/ES → DE est-il réaliste ? Faut-il accélérer l'internationalisation ?
7. **Concurrence** : risque que Nextmune ou Heska descendent en gamme dans les 24 mois ?

ANNEXES

Documents disponibles sur demande :

- **A.** Market Evidence Pack v1 — Analyse marché, gaps allergéniques, recommandations produit
- **B.** Claims Matrix FR — Allégations autorisées/interdites, positionnement concurrentiel
- **C.** Matrice concurrentielle détaillée — Nextmune, Heska, IDEXX, Laboklin, tests génériques
- **D.** DEC-001 — CCD Interference Policy
- **E.** DEC-002 — Architecture produit 3 SKUs régionaux
- **F.** Protocole KOL — n ≥ 30, questionnaire allergènes, logigrammes DBS
- **G.** Dossier technique et clinique fusionné (bilingue FR/EN)
- **H.** Fiches techniques Zheda Dixun
- **I.** Business Plan Excel 5 ans (modèle financier complet)
- **J.** Tableau de bord financier — milestones, facturation, livrables
- **K.** Analyse du potentiel de marché vétérinaire France

RÉFÉRENCES

[1] Cornell University College of Veterinary Medicine — « Atopic dermatitis (atopy) » : *« Atopic dermatitis is a common skin disease characterized by excessive itchiness (pruritis), and it may affect as much as 10-15% of the dog population. »* — https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/atopic-dermatitis-atopy

[2] Dove Medical Press / Veterinary Medicine: Research and Reports (2024) — « Canine Atopic Dermatitis: Prevalence, Impact, and Management Strategies » : *« The prevalence of CAD has been estimated at 3-15%. »* — https://www.dovepress.com/canine-atopic-dermatitis-prevalence-impact-and-management-strategies-peer-reviewed-fulltext-article-VMRR

[3] FEDIAF — Facts & Figures 2025 (populations animales Europe)

[4] Données financières : extraites du modèle `Vetalyx BP.xlsx` (business plan 5 ans)

.